

Fecha Última Actualización: 01-09-2022 20:29:32

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Ismael Del Transito Rios Chacana **Rut** : 10.713.989-3 **N° Archivo** : 2213284
Edad : 58a 10m 8d **Fecha Nacto**: 24/10/1963 **Sexo** : Masculino
Dirección : Psje Antiyuf 1824 Dep 22 A V Padre Hurta **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 9 6832 5255

N° Epicrisis
313670

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Pre-Hospitalizacion **Fecha Ingreso** : 02/07/2022 19:08 **Días Estadía**: 61
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Egreso** : 01/09/2022 20:09

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dificultad respiratoria

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Ismael Del Tránsito Ríos Chacana
Edad: 58 años
RUT: 10.713.989-3
FI CASR: 02/07/22
FI UPC: 05/07/22

ANTECEDENTES:

Mórbidos: fibrosis pulmonar (post COVID?) requerimientos de oxígeno domiciliario hace 2 meses no enlistado a trasplante pulmonar, hipotiroidismo.

Medicamentos: Eutirox 150 mg, Cotrimoxazol forte 1 comp trisemanal, Prednisona 20 mg (suspendido 1 semana previo al ingreso), Pirfenidona.

Qx: -

Alergias: -

Inmunizaciones: 2 vacunas COVID

Hospitalizaciones recientes: 2020 COVID grave que requirió IOT

MC: dificultad respiratoria y cianosis

HISTORIA DE INGRESO

Paciente con antecedentes descritos, acude al servicio de urgencias de esta institución el 02/07/2022 con cuadro clínico de dos semanas de evolución caracterizado por disnea progresiva, tos productiva mucopurulenta / hemoptoica y aumento de requerimientos de oxígeno domiciliario; el 01/07/2022 sumó fiebre de hasta 38°C y dolor torácico.

PCR SAS COV 2 negativa.

Inicia ventilación mecánica no invasiva, corticoides y broncodilatación; respuesta inicial adecuada se de escala a cánula de alto flujo a 55 L y FiO2 60%, inicia ampicilina sulbactam. Inicia trámite de egreso al hospital del tórax por posibilidad de trasplante pulmonar.

El 04/07/2022 evoluciona con profundización de su falla respiratoria, requiere intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, difícil de ventilar por rigidez pulmonar, agregan relajación neuromuscular mejorando la adaptación a la ventilación mecánica, falla respiratoria mixta con acidosis respiratoria y acidosis metabólica concomitante, en falla renal aguda e hiperkalemia.

Fecha Epicrisis : 01/09/2022 20:29

Página 1 de 3

En ese contexto, en la fecha ingresa a UCI a cama disponible.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO A UPC:

- 1.Shock séptico foco respiratorio + FOM
 - a.EPID exacerbada
- 2.Insuficiencia respiratoria aguda global
 - a.VMI 04/07 a la fecha.
- 3.Falla renal aguda prerrenal KDIGO 2
 - a.Acidosis metabólica con AG aumentado
 - b.Hiperkalemia
- 4.Antecedentes: EPID.

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN:

1)HDN: inicialmente inestable en contexto de shock séptico con requerimientos de DVA NA hasta dosis moderadas, que suspende precozmente. Una vez resuelto shock, suspensión de DVA. De ahí destacó presencia de BH acumulados positivos manejados con terapia depleitiva.

2) Respiratorio: insuficiencia respiratoria aguda global grave al ingreso en contexto de EPID exacerbada. Durante estadía inicial destaca pulmón rígido y deterioro gasométrico, con requerimientos de BNM. Evolución con lento destete, por lo que sale a TQT percutánea, procedimiento realizado el 17/08. Evolución inicialmente favorable, queda en plan de rehabilitación.

3)Infeccioso: cursó con intercurencias infecciosas todas tratadas. En último CAET se rescata PSAE MS que se encontraba en tratamiento con Ciprofloxacino.

4) Neurológico: evoluciona con dolor en extremidad inferior derecha/pie derecho de carácter neuropático asociado a paresia M2 ipsilateral, sin lesiones evidentes ni signos de TVP. Se inició tratamiento con Pregabalina y Paracetamol, con lenta pero favorable respuesta.

5) Psiquiátrico: trastorno adaptativo con síntomas ansiosos en tratamiento con Duloxetina + Pregabalina + Quetiapina nocturna y Clonazepam en plan de suspensión de este último gradual. Se mantuvo en seguimiento por especialidad.

En relación a aumento de secreciones, mala tolerancia a VMNI, disfonía, se plantea cambio a TQT de menor calibre, procedimiento realizado el 30/08, que resulta con caída de coágulo hacia la tráquea y obstrucción de vía aérea superior asociado a gran dificultad para ventilación. Se intenta bajo FBC extracción de coágulo, procedimiento complejo.

Evoluciona con importante deterioro de lo respiratorio y lo hemodinámico, con req DVA hasta NA 1.5 ug/kg/min. Se solicita Rx tórax control, que muestra signos sugerentes de Neumotórax izquierdo. Se interpreta como neumotórax a tensión, se realiza punción con trocar 14G con salida de aire abundante. Se instala pleurostomía izq, proced imiento sin incidentes.

Pese a resolución de neumotórax y resolución de obstrucción Vía aérea superior, evoluciona hipoxémico, taquicárdico, con req DVA al alza. Dado pronóstico determinado por EPID y paciente no enlistado a trasplante, se desestima ECMO.

Se da aviso a familia.

Paciente fallece el 01/09/22 a las 20:20 en compañía de sus familiares.

DIAGNÓSTICOS DE FALLECIMIENTO

- 1.Insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica.
 - a. Neumotórax a tensión resuelto
 - b. Obstrucción de vía aérea superior.
 - c. Traqueostomía por lento weaning.
 - d. EPID exacerbada por NAC sin microbiología demostrada resuelta

Diagnóstico de Egreso

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA -
OTRAS ENFERMEDADES PULMÓNALES INTERSTICIALES CON FIBROSIS -

Fecha Última Actualización: 01-09-2022 20:29:32

Página 3 de 3

Condición de Egreso Fallecido

Fallece el __/08/22 a las __:__.
Se emite certificado de defunción.

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Cuerpo a Anatomía Patológica.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Absoluto

Régimen Alimentario : Hídrico

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Nicolas Lopez Valenzuela
Becado/Residente



Eduardo Cisternas Fuentes
Médico Tratante (Staff)